



NOTULENSI

HARI / TANGGAL : 24 Mei 2023
PUKUL : 08:00:00
JENIS MEETING : Rapat Koordinasi dengan Bee Tu
TEMPAT : Ruang Meeting Kantor PT. DPM

Berikut hasil
notulen

NO.	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Penyampaian hasil PPS oleh Kepala Bidang Mutu dan Pelayanan PT DPM	1. Hasil PPS yang harus dilakukan 2. Penggunaan redowsko di masing – masing RS	1. Untuk hasil PPS di upload pada sidokar 2. Untuk bukti dilakukan pembaruan setiap 6 bulan sekali 3. Redowsko masing – masing RS di daftarkan untuk asesor internal dan ketua akreditasi 4. Redowsko hanya bisa di akses di lingkungan RS 5. Untuk RSPHM pada link pengambilan sampel masih belum bisa jadi IT komunikasi langsung dengan IT KARS (Mas Andi) 6. Target seminggu lagi untuk dibuatkan pelatihan redowsko 7. Masing – masing RS mengajukan pelatihan asesor internal dari KARS	Tim Akreditasi
2.	Manajemen RSPHM PPS TKRS RSPHM TKRS 2 : Pimpinan rumah sakit memilih dan menetapkan proses pengukuran, pengkajian data, rencana perbaikan dan mempertahankan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di lingkungan rumah sakit	Fakta dan Analisis : ditelusur ditemukan data di upload dengan tdk diatur waktunya	1. Untuk umandok dilengkapi dengan materi dari hasil sosialisasi mutu 2. Untuk supervisi PMKP dicantumkan 3. IT membuat link yang mudah diakses untuk pemenuhan bukti bukti pada PPS	PJ TKRS, PMKP, IT dan Manajemen
	TKRS 4 : Pimpinan rumah sakit menetapkan mekanisme pemantauan dan koordinasi program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.	Fakta dan Analisis : dalam telusur ditemukan tata letak ruang yg belum memenuhi standart	1. Update data PPS setiap 6 bulan sekali pada sidokar 2. Untuk pemenuhan standart ruangan yang telah di lengkapi dilakukan upload pada sidokar	PJ TKRS, MFK dan Manajemen
3.	PPS PMKP RSPHM PMKP 5 : Rumah sakit telah melakukan validasi berbasis bukti meliputi poin a) hingga f) yang ada pada maksud dan tujuan.	Fakta dan Analisi : ditemukan up load data oleh PIC perunit dengan tdk ditetapkan waktu upload nya	1. Untuk pulita dibuatkan SK ulang 2. Untuk yang melakukan validasi adalah masing masing kepala ruang dan PMKP 3. Dilampirkan hasil supervisi pada laporan bulanan 4. Untuk rekapan hasil supervisi dengan hasil prosentase	PJ PMKP, Kepala Ruang, dan Manajemen
	PMKP 10 : Hasil pengukuran budaya sebagai acuan dalam menyusun program peningkatan budaya keselamatan di rumah sakit.	Fakta dan Analisis : ditelusur rawat inap ditemukan upload data mutu dan PPI oleh PIC unit tdk diatur	1. Pelatihan untuk petugas penginput data, pengganti apabila pulita mutu unit dan KARU sedang tidak bertugas 2. Membuat SPO supervisi agar supervisi bisa dikerjakan sesuai dengan standart	PJ PMKP, Kepala Ruang, dan Manajemen
4.	PPS MFK RSPHM MFK 2 : Penanggungjawab MFK telah melakukan pengawasan dan evaluasi Manajemen Fasilitas dan	Fakta dan Analisis : ditemukan tata kelola ruang yg belum memenuhi aturan	1. Ditambahkan ventilasi pada ruang b3 2. Dilakukan supervisi oleh MKF 3. Bahwa untuk kedepan hasil dari asesor internal harus	PJ MFK, K3RS dan Manajemen

	Keselamatan (MFK) setiap tahunnya meliputi poin a) hingga g) dalam maksud dan tujuan serta melakukan penyesuaian program apabila diperlukan.		dianggap penting, untuk menjadikan jalan keluar	
			4. Dilakukan pengawasan dan evaluasi dimulai dari inventarisasi	
5.	PPS PKPO RSPHM PKPO 3 EP 3 Rumah sakit melaksanakan supervisi secara rutin oleh apoteker untuk memastikan penyimpanan sediaan farmasi dan BMHP dilakukan dengan benar dan aman	Fakta dan Analisis : ditemukan tata kelola obat yg belum terkelola dengan baik	1. Dibuatkan surat pengantar terkait berita acara. Apabila obat DINKES dibuatkan pengantar ke DINKES apabila obat RS maka dibuatkan surat pengantar ke PT DPM 2. Umandok pada saat akan dilaksanakan pemusnahan dilampirkan juga 3. Dibuat surat pengantar dari Direktur RS sebelum pelaksanaan pemusnahan	PJ PKPO, Kepala Ruang IKO, Manajemen
	PKPO 3.3 EP 4 Rumah sakit menerapkan proses pemusnahan sediaan farmasi dan BMHP	Fakta dan Analisis : ditelusur ditemukan tata kelola obat di OK kurang terkelola	1. Untuk system floorstok sudah ada system barang di IKO 2. Farmasi memenuhi kebutuhan di IKO 3. Untuk komunikasi antara farmasi dan IKO sudah bisa dilihat di SIMRS untuk system yang ngelink antara IKO dan farmasi 4. Untuk penataan farmasi di ruang IKO dipindah di ruangan yg lebih tertutup sesuai dengan standart untuk menghindari risiko hilang (dicuri) 5. Supervisi di ruang farmasi iko : penyimpanan dan pemantauan yang dilakukan setiap hari oleh apoteker rawat inap 6. Untuk format supervisi pada system google spreadsheet. Setiap hari diganti sesuai dengan stok minimal	PJ PKPO, Kepala Ruang IKO, Manajemen
6.	PPS PPI RSPHM PPI 2 : Rumah sakit melakukan evaluasi pelaksanaan program PPI	Fakta dan Analisis : ditemukan di telusur upload belum diatur	1. Penginputan data dilakukan pada pukul 08.00 – 14.00 sesuai dengan SPO yang terbaru 2. Untuk yang melakukan penginputan IPCN atau IPCLN atau sama dengan PJ mutu 3. Untuk keputusan direktur permenkes harus masuk 4. Untuk poin kebijakan di SPO di tulis kalimatnya dan didalam harus dicantumkan regulasi yang berlaku di RS Prima Hsuada karena didalam regulasi RS Prima Husada wajib / harus ada regulasi diatasnya yang berasal dari regulasi pemerintah yang berlaku 5. Penginputan data masuk dalam SIMRS ? masuk dalam pedoman PPI 6. SPO ditambahkan dimasukkan data di inputkan pada SIMRS 7. Ditambahkan untuk asesor internal bekerja : kepala unit / IPCLN harus ikut dilakukan pengambilan sampel 1 8. Lebih diperinci lagi untuk supervisi IPCN 9. Memastikan program PPI dilaksanakan dengan benar ? tugas IPCN 10. Dilakukan rekomendasi untuk penambahan IPCN ?	PJ PPI dan Manajemen

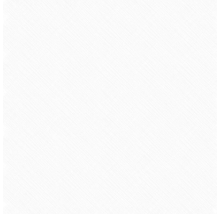
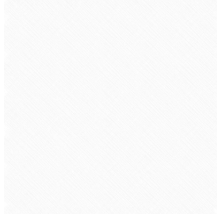
			perencanaan 11. Dibuat seperti PKPO untuk supervisi. Berdasarkan tugas dari IPCLN 12. IPCN harus sesuai dengan standart dan memastikan program – program PPI dilaksanakan dengan betul	
	PPI 7 : Rumah sakit telah menerapkan pengelolaan limbah rumah sakit untuk meminimalkan risiko infeksi yang meliputi a) sampai e) pada maksud dan tujuan (PPI 7)	Fakta Analisis : di telusur di temukan di TPS B3 di tumpuk tidak memperhatikan cara pengambilan waktu diangkut oleh pihak ke 3 ventilasi tdk baik ada bau yang tercium	1. Untuk pengangkutan B3 transporter melakukan pengambilan dengan petugas didalam B3 2. Koordinat pada tempat B3 sudah ada dan terpasang di ruang TPS B3 3. Pengikatan B3 harus rapat agar tidak bocor dengan cara diputar lalu di ikat 4. Untuk TPS harus selalu di kunci 5. Untuk penyimpanan kunci dilakukan oleh kesling ? ditambahkan pada SPO 6. Ditambahkan untuk pembersihan B3 yang aliran airnya disambungkan ke ipal 7. Dibikin secara periodik untuk pembersihan dan saluran limbah yang nyambung dengan IPAL	PJ PPI dan Manajemen
8.	AKP RSPHS AKP 1.2 Rumah sakit telah menerapkan proses skrining baik di dalam maupun di luar rumah sakit dan terdokumentasi.	Fakta dan Analisis : Belum ada dokumentasi skrining di luar rumah sakit	1. Dokumen skrining untuk pre rujuk Urutan: 1. Petugas penerima telfon (memberi advice dan dilakukan pencatatan terkait instruksi yang diberikan) ataupun data – data pasien 2. Buku untuk pencatatan diusahakan satu saja dan diberi keterangan dan disesuaikan dengan alur	PJ AKP, Kepala Ruang IGD, Manajemen
	AKP 2.1 Rumah sakit telah menerapkan proses skrining baik di dalam maupun di luar rumah sakit dan terdokumentasi.	Fakta dan Analisis : Pengelolaan alur pasien belum menunjukkan bukti dilakukan evaluasi secara berkala	Asal pasien di rujuk ke RSPH ada 3 macam yaitu : pasien datang dari rumah, FKTP, KLL di jalan raya. Untuk pasien bisa datang sendiri maupun di jemput dengan ambulance RSPH Catat semua informasi dibuku registrasi pasien IGD sebaga bahan untuk mengisi RM saat pasien datang untuk bukti komunikasi di lampirkan	
	AKP 5.7 : Proses tersebut dievaluasi untuk memenuhi kebutuhan para DPJP dan pelayanan asuhan yang kompleks meningkatkan mutu serta keselamatan pasien.	Belum ada dokumen evaluasi upaya untuk memenuhi kebutuhan para DPJP dalam memberikan pelayanan asuhan yang kompleks pada pasien rawat jalan	1. Pembuatan SPO terkait pengisian PRMRJ 2. Kriteria untuk pasien pasien yang dituliskan ke dalam PRMRJ dan dimasukkan kedalam SPO (disesuaikan dengan Pedoman yang ada)	PJ AKP, Kepala Ruang IRJA, Manajemen
	Pelatihan HPK RSPHS : HPK 1 : Semua staff dilatih tentang proses dan peran mereka dalam mendukung hak-hak serta partisipasi pasien dan keluarga dalam perawatan.	Fakta dan Analisis : Belum ada pelatihan staf mengenai peran mereka mendukung hak pasien dan keluarga dalam perawatan	1. Pelatihan HPK dimasukkan dalam materi edukasi yang diikuti oleh seluruh staf. Untuk materi edukasi oerientasi ruangan metodenya dengan media video 2. Materi terkait pelatihan HPK bersifat aplikatif disesuaikan dengan bab dalam akre. Materi bisa dipermudah dalam bentuk video sehingga bisa dipergunakan berulang kali.	PJ HPK, SDM Diklat, Manajemen
	PAP RSPHS PAP 1.1	Fakta dan Analisis : Tindakan yang dilakukan PPA tidak	1. Hasil yang diharapkan dari Tindakan yg telah dilakukan	PJ PAP, Kepala Ruang

	Elemen Penilaian : Prosedur dan tindakan telah dilakukan sesuai instruksi dan PPA yang memberikan instruksi, alasan dilakukan prosedur atau tindakan serta hasilnya telah didokumentasikan di dalam rekam medis pasien	Selalu disertai dokumentasi hasil Permasalahan : 1. Mana yang harus masuk general consent atau informed consent 2. Untuk tindakan pasang cateter menurut dr. Setya Budi, Sp. OG masuk pada general consent, sedangkan pedoman yang berlaku di RSPH untuk pemasangan cateter masuk pada informed consent (cari literatur / regulasi)	adalah asuhan sesuai dengan standar 2. Isi dari Informed Consent dan General Consent harus dipahami oleh semua PPA dan disesuaikan dengan pedoman agar dapat memberikan pelayanan yang seragam 3. Apabila terjadi penolakan ketika di KIE terkait informed consent, diberikan informasi risiko apabila terjadi penolakan 4. General consent dan Informed consent disesuaikan dengan kebijakan Rumah Sakit	Pelayanan, Manajemen
	PAP 1.2 Elemen Penilaian : Rencana asuhan pasien dibuat dengan membuat sasaran yang terukur dan di dokumentasikan. Fakta dan Analisis : Rencana asuhan pasien dibuat dengan membuat sasaran yang terukur dan di dokumentasikan.	Elemen Penilaian : Rencana asuhan belum mencantumkan sasaran yang terukur	1. Stample konfirmasi di lakukan pada catatan terintegrasi. Edukasi DPJP diletakkan di CPPT dengan di stemple yang diisi dengan lengkap, DPJP TTD, pasien / keluarga TTD agar DPJP mudah untuk mendokumentasikan 2. Di form asesmen awal medis ada rencana asuhan yang harus diisi oleh DPJP 3. Untuk asuhan pemberian asuhan yang diberikan oleh perawat bisa dilihat secara rinci di Asuhan Keperawatan 4. Penulisan asuhan keperawatan bisa disesuaikan dengan kebijakan yg ada di RS	PJ PAP, Kepala Ruang Pelayanan, Manajemen
	PAP4 Elemen Penilaian : Staf rumah sakit mendapatkan pelatihan mengenai cara melakukan edukasi bagi pengelolaan nyeri	Fakta dan Analisis : Ada pelatihan komunikasi efektif belum ada bukti pelatihan pengelolaan nyeri bagi Staf rumah sakit	Dilakukan untuk edukasi nyeri yaitu cara meng edukasi pengelolaan nyeri belum dilakukan oleh perawat. Upaya mengurangi nyeri dengan cara non farmokologi (untuk materi dibuatkan oleh tim PKRS) yang di sampaikan kepada pasien / keluarga pasien	PJ PAP, Kepala Ruang Pelayanan, Manajemen
	KE RSPHS KE 5 : Proses pemberian edukasi di dokumentasikan dalam rekam medik sesuai dengan metode edukasi yang dapat diterima pasien dan keluarganya.	Fakta dan Analisis : Dokumentasi edukasi pasien belum selalu mencantumkan metode edukasi dan rincian informasi yang diberikan	1. Masih belum tertulis lengkap terkait dokumen RM 2. Laporan supervisi harus tetap berjalan	PJ KE, Kepala Ruang Pelayanan, Manajemen
	SKP RSPHM SKP 2 : Rumah sakit telah menerapkan komunikasi jenis serah terima tetapi belum saat serah terima sesuai dengan jenis serah terima lengkap meliputi poin 1)-3) dalam maksud dan tujuan.	Fakta dan Analisis : Ada proses penerapan komunikasi saat serah terima sesuai dengan jenis serah terima tetapi belum saat serah terima sesuai dengan jenis serah terima lengkap	1. Proses operan harus dilakukan oleh perawat IGD dengan menunjukkan buku operan 2. Pemberian obat bisa didelegasikan dan penyerahan obat bisa dilakukan KIE kepada pasien dan keluarga pasien 3. Ketidaktepatan Perawat dan Dokter terkait hand hygiene dicantumkan sebagai bukti untuk PPS SKP 4. Diklat dan supervisi terkait kepatuhan hand hygiene harap ditingkatkan 5. Evaluasi kinerja dikaitkan dengan semua bab yg belum dipatuhi ? buat kebijakannya	PJ SKP, Seluruh Kepala Ruang, SDM dan Manajemen
	SKP 3.2 : Rumah sakit menerapkan pengelolaan obat kewaspadaan tinggi (High Alert) termasuk obat Look -Alike Sound Alike (LASA) secara seragam di seluruh	Fakta dan Analisis : Bukti pelaksanaan tentang penyediaan penyimpanan penataan penyiapan dan penggunaan obat yang perlu diwaspadai High Alert termasuk obat Look Alike Sound Alike LASA	Sosialisasi terkait SPO pemberian obat dan double check sebelum pemberian obat	PJ SKP, Seluruh Kepala Ruang, SDM dan Manajemen

	area rumah sakit untuk mengurangi risiko dan cedera	belum konsisten		
	SKP3.3 : Rumah sakit mengevaluasi dan memperbaharui daftar obat High-Alert dan obat Look -Alike Sound Alike (LASA) yang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali berdasarkan laporan insiden lokal, nasional dan internasional.	Fakta dan Analisis : Ada proses mengevaluasi dan memperbaharui daftar obat High Alert dan obat Look Alike Sound Alike LASA yang sekurang-kurangnya 1 satu tahun sekali berdasarkan laporan insiden lokal nasional dan internasional tetapi insiden lokal, nasional dan internasional belum terdokumentasikan dengan baik dan lengkap Hasil Temuan : 1. Penemuan di Irna terkait perawat tidak double check 2. Penemuan obat high alert tanpa label dan tanpa etiket	1. Supervisi terkait obat obat LASA 2. Supervisi terkait SKP masih belum dimasukkan	PJ SKP, Seluruh Kepala Ruang, SDM dan Manajemen
	PAB RAPHM PAB 2 : Rumah sakit telah menetapkan penanggung jawab pelayanan anestesi dan sedasi adalah seorang dokter anestesi yang kompeten yang melaksanakan tanggung jawabnya meliputi poin a)sampai d) pada maksud dan tujuan.RSPHM	Fakta dan Analisis : Penanggung jawab anestesi masih menjadi satu dengan penanggung jawab bedah sentral yang ketuanya adalah dokter spesialis anestesi organisasinya belum terpisah	1. Tidak masalah apabila dipisah sesuai dengan kebijakan RS 2. Untuk pelayanan anestesi ada program kerja tersendiri 3. Pedoman pelayanan anestesi dan pedoman kamar operasi dibuat terpisah 4. Pedoman pengorganisasian dibuat 1 yaitu pedoman pengorganisasian	PJ PAB, Manajemen
	PAB 4.3 : Kedua pengkajian tersebut telah dilakukan oleh PPA yang kompeten dan telah diberikan kewenangan klinis didokumentasikan dalam rekam medis pasien.	Fakta dan Analisis : Dokumentasi pengkajian pra induksi dan pra anestesi di rekam medis belum dilakukan secara konsisten	Jika pasien yang terpasang implan pindah rumah maka di menghubungi PIPP dan dimasukkan didalam pedoman pelayanan bedah. Menambahkan tupoksi pendaftaran, PIPP, rekam medis	PJ PAB, Manajemen
	PAB 7.4 : Rumah sakit mempunyai proses untuk melakukan implan medis yang telah digunakan pasien.	Hasil Temuan : Pelayanan anestesi bedah sentral dan anestesi di pisah	1. Untuk program kerja anestesi dibuatkan terpisah dan dijadikan satu di program instalasi kamar operasi 2. SK dibuatkan 2 dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An ? koordinasi dengan SDM 1 SK untuk kepala IKO dan 1 SK untuk penanggung jawab pelayanan anestesi 3. Dilakukan pengelompokan terkait pelayanan yang ada di IKO	PJ PAB, Manajemen
	PAP RSPHM PAP 1.1 : Pasien yang menjalani tindakan invasif/berisiko di rawat jalan telah dilakukan pengkajian dan didokumentasikan dalam rekam medis	Fakta dan Analisis : Pengkajian awal tindakan invasif berisiko di rawat jalan belum dilaksanakan dengan konsisten	1. Injeksi intraarticular harus dilengkapi dengan pengkajian awal rawat jalan 2. Tindakan invasif yang berisiko tinggi dirawat jalan harus di data 3. Dibuat pedoman harus dilakukan pengkajian awal yang di supervisi 4. Harus dipastikan kondisi pasien baik sebelum dilakukan tindakan 5. Harus ada bukti apabila sudah dilakukan pengkajian awal 6. Revisi pedoman verifikasi cppt dilakukan 24 jam karena ttd verifikasi 1x24 jam 7. Dibuatkan aturan untuk penunggu yang membawa makanan dari luar ? dibuatkan pedoman 8. Infomed consent pemberian analgetic dijadikan satu dengan informed consent pemberian pra bedah / pra anestesi	PJ PAP, Manajemen

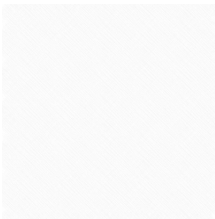
	PAP 1.2 : Rencana asuhan dievaluasi secara berkala, direvisi atau dimutakhirkan serta didokumentasikan dalam rekam medis oleh setiap PPA.	Fakta dan Analisis : Dari bukti di RM rawat inap proses analgetic dijadikan satu dengan informed consent pemberian pra bedah / pra anastesi		
	PAP 2.1 : Rencana asuhan dievaluasi secara berkala, direvisi atau dimutakhirkan serta didokumentasikan dalam rekam medis oleh setiap PPA.	Fakta dan Analisis : Proses pemantauan dn evaluasi kegiatan pelayanan geritatri belum dilakukan secara konsisten sesuai dengan pelayanan geriatri tingkat lengkap sempurna	1. Dibuatkan SK untuk geriatric di rawat inap 2. Revisi pedoman disertai dengan monev 3. Pedoman geritri sesuai dengan PMK no 79 tahun 2014 4. Untuk geriatric dibuat untuk geriatric tingkat sederhana 5. Diidentifikasi dari jejaring rujukan dan poli rawat jalan dan rawat inap untuk mendata jumlah pasien geriati	
	PAP 4 : Informasi mengenai kemungkinan adanya nyeri dan pilihan tata laksananya diberikan kepada pasien yang menerima terapi/prosedur/pemeriksaan terencana yang sudah dapat diprediksi menimbulkan rasa nyeri.	Fakta dan Analisis : Bukti bahwa pasien atau keluarga telah dilakukan edukasi tentang kemungkinan timbulnya nyeri pasca tindakan belum dilakukan secara konsisten	Bukti pemberian edukasi kepada pasien yang membawa pasien dari luar masuk dalam ceklis orientasi pasien masuk ? di lakukan oleh petugas pendaftaran dan di supervise	
	PONEK RSPHS	PN 1.1 : Telah dilakukan evaluasi program pembinaan jejaring rujukan.	1. Evaluasi pembinaan dari jejaring terutama IBI harus lebih dilengkapi 2. Evaluasi dibuat dalam bentuk data sehingga tau berapa % yang belum berjalan sesuai dengan standar 3. SPO diberikan kepada bidan perujuk agar tau terkait standar 4. Pemberian edukasi masih belum dimasukkan kedalam checklist rujukan 5. Kendala dari SISROUTE bisa dimasukkan kedalam evaluasi dari rujukan 6. SK PIC dari jejaring rujukan SPO terkait jejaring rujukan juga harus dilengkapi	PJ Ponek, Manajemen
	HPK RSPHM HPK 1.5 : Rumah sakit mengembangkan dandan menerapkan proses untuk melindungi semua pasien dari serangan fisik dan verbal.	Fakta dan Analisis : Rumah sakit regulasi SPO sudah ada tetapi belum mengembangkan dandan menerapkan proses untuk melindungi semua pasien dari serangan fisik dan verbal termasuk populasi khusus KDRT	1. Identifikasi perilaku kekerasan misal kekerasan oleh karena itu perlu ada SPO apabila terjadi prilaku kekerasan 2. CCTV tidak perlu dipantau terus menerus 3. CCTV ada 2 jenis yaitu : memantau dan pencegahan 4. Membuat SPO mitigasi kekerasan	PJ HPK dan Manajemen
	HPK 2 Poin 1 : Rumah sakit menerapkan proses untuk mendukung pasien dan keluarga terlibat dan berpartisipasi dalam proses asuhan dan dalam pengambilan keputusan.	Fakta dan Analisis : Ada penerapan proses untuk mendukung pasien dan keluarga terlibat dan berpartisipasi dalam proses asuhan dan dalam pengambilan keputusan tetapi belum terdokumentasikan dengan baik dan lengkap	Ditambahkan untuk lembar edukasi. Bukti yang paling bagus yaitu peragaan pemberian edukasi partisipasi	
	HPK 2 poin 3 : Pasien diberikan informasi mengenai hasil asuhan dan tata laksana yang diharapkan.	Fakta dan Analisis : Ada proses pasien diberikan informasi mengenai hasil asuhan dan tata laksana yang diharapkan tetapi belum lengkap didokumentasikan	Dijadikan satu di pedoman pemberian edukasi “bahwa DPJP menulis di CPPT dan ada stemple khusus sesuai dengan rincian”	
	AKP RSPHM AKP 1.2 : Staf yang kompeten dan berwenang di unit pelayanan khusus dan unit	Fakta dan Analisis : Staf yang kompeten telah bekerja tetapi hasilnya belum lengkap karena belum ada kriteria secara subjektif yang berdasar fisiologis	1. Umandok rapat menentukan pasien keluar masuk ICU 2. Dibuatkan kriteria keluar masuk ICU 3. Diklat staf ICU belum 100 %	PJ AKP, Kepala Ruang ICU, SDM dan Manajemen

	pelayanan intensif terlibat dalam penyusunan kriteria masuk dan kriteria keluar di unitnya.		4. Target 100 % petugas ICU tersertifikasi 5. Dimasukkan dalam RBA diklat SDM. 6. Dibuatkan untuk umandok rapat sebagai acuan keluar masuk ICU 7. Perencanaan internal : penyediaan biaya untuk diklat ICU dan NICU 8. Membuat kriteria penundaan pelayanan	
	AKP 5.5 : Selama proses rujukan ada staf yang kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu memantau dan mencatatnya dalam rekam medis.	Fakta dan Analisis : Staf yang kompeten belum konsisten melakukan pemanataan kondisi selama rujukan dan bukti dalam rekam medis juga belum konsisten	Untuk rujukan dari luar dimasukkan di rekam medis pasien dan ditambahkan untuk tupoksi ICU, SDM dan pendamping rujuk ditambahkan pada pedoman	PJ AKP, Kepala Ruang ICU, SDM dan Manajemen
	AKP 5.7 Poin 2 : Dokter keluarga (bila ada) atau dokter yang memberikan asuhan berikutnya kepada pasien diberitahu tentang kondisi tersebut	Fakta dan Analisis : PRMRJ belum secara konsisten dibuat untuk pasien rawat jalan yang memerlukannya	E RM pada rawat jalan diisi secara realtime dan dilakukan money kepada DPJP masing – masing poli	PJ AKP, Kepala Ruang ICU, SDM dan Manajemen
	AKP 5.7 poin 3 : Proses tersebut dievaluasi untuk memenuhi kebutuhan para DPJP dan meningkatkan mutu serta keselamatan pasien.	Fakta dan Analisis : Belum ada bukti telah dilakukan evaluasi PRMRJ	Ditulis untuk evaluasi AKP 5.7 EP 3 adalah 0 masih belum berjalan	PJ AKP, Kepala Ruang ICU, SDM dan Manajemen
	KE RSPHM KE 2 : Akses mendapatkan informasi kesehatan diberikan secara tepat waktu, dan status sosial ekonomi perawatan pasien tidak menghalangi pasien dan keluarga untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.	Fakta dan Analisis : Ada proses penerapan komunikasi saat serah terima sesuai dengan jenis serah terima tetapi belum didokumentasikan dengan baik dan lengkap	1. Dilakukan serah terima dari perawat poli ke IGD 2. Dibuatkan SPO atau pedoman terkait serah terima 3. Untuk formulir serah terima dari igd dilakukan ttd dari IGD keruangan dan ruangan ke IGD 4. Dibuatkan SPO terkait operan jaga di IGD dan dimasukkan dalam pedoman	PJ Bab KE
	KE 3 : Hambatan dari pasien dan keluarga dalam menerima edukasi dinilai sebelum pemberian edukasi dan dicatat di rekam medis.	Fakta dan Analisis : pengkajian terhadap hambatan kemampuan dan Keterbatasan fisik dan kognitif pasien dan keluarga kurang spesifik kurang pendengaran dicatat di rekam medis	1. Survei PPS kemungkinan dari Dinas 2. Pencatatan dalam rekam medis terkait edukasi kepada pasien dan keluarga pasien wajib ditulis 3. Bukti – bukti harus lebih kuat	PJ Bab KE
	Kesimpulan	Hasil Presentasi PPS tiap masing – masing bab	1. Antara elemen dan rekomendasi harus sesuai 2. Proses kriteria keluar masuk icu di jelaskan juga terkait kriteria kompetensi 3. Didaftarkan untuk redowsko pada masing masing RS ? konfirmasi IT 4. Target minggu depan untuk pelatihan redowsko 5. Usulkan ke PT diwajibkan untuk diklat asesor internal 6. pps untuk suatu perbaikan terus menerus 7. harus punya argumentasi untuk menerangkan terkait survei akreditasi 8. dilakukan perbaikan terus menerus untuk perbaikan mutu di RS 9. follow up terkait redowsko untuk ngelink ke sidokar ? koordinasi dengan IT	Tim Akreditasi Rumah Sakit dan Manajemen



Man Admin Persuratan, In., Black

Mengetahui



0

DOKUMENTASI